

شیوه نامه

"تشکیل کارگروه

پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین"

ویژه دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

بهمن ماه سال ۱۴۰۲

نسخه ۱-۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس
اداره سلامت مادران

بسمه تعالی

شیوه نامه

"تشکیل کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین - ویژه دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی"

مقدمه

با توجه به تبعات جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی سقط عمدی جنین، احتمال مرگ مادر و همچنین اثرات سوء آن بر خانواده و جامعه و نیز با توجه به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر "ممنوعیت سقط جنین و معرفی آن به عنوان جرائم دارای جنبه عمومی که مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است" و به منظور تسهیل و اجرای هرچه موثرتر این ماده قانونی، براساس مصوبه ششم شانزدهمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (شماره نامه ۳۰۰/۲۲۱۰۸ د تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۱ اقدامات خود نسبت به تشکیل کارگروه "پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین" را آغاز نمود. با توجه به اهمیت و جایگاه موضوع و درخواست دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ریاست جمهوری به شماره نامه های ۱۹۱۵۷۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (شماره ثبتی ۱/۶۸۹۵۶) و ۲۱۱۱۵۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ (شماره ثبتی ۱/۷۵۴۴۵)، لازم است کارگروهی متناظر در سطح دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور تشکیل گردد.

ماده ۱: تعاریف و اختصارات

۱-۱: ستاد مرکزی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲-۱: دانشگاه/دانشکده: دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور.

۳-۱: قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، که در جلسه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.

۴-۱: ماده قانون: ماده ۵۶ قانون با موضوع ممنوعیت سقط جنین.

۵-۱: کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین: کارگروهی متشکل از افراد حقوقی که نمایندگان معاونت‌ها، مراکز، ادارات و دفاتر ستاد مرکزی در سطح ملی و متناظر آنان در سطح دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هستند که ذی‌نفع و/یا مرتبط با موضوع ماده ۵۶ قانون می‌باشند.

۶-۱: سقط عمدی جنین: سقط جنین به دلایلی غیر از دلایل طبی (اندیکاسیون‌های مادری و/یا جنینی) و خود به خودی.

ماده ۲: اهداف

در راستای دستیابی به اهداف ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص ممنوعیت سقط جنین، این کارگروه در سطح دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به‌منظور پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین با اهداف زیر تشکیل می‌گردد:

۱. اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه پزشکی-پیراپزشکی، داروخانه‌ها، عطاری‌ها، تجهیزات پزشکی و ... در بخش دولتی و خصوصی در زمینه دستورعمل‌ها، قوانین و مجازات‌های مرتبط با سقط جنین عمدی.
۲. ترویج رویه‌های فرهنگ‌سازی، جهت ارتقا آگاهی، نگرش و عملکرد ارایه دهندگان، خدمت گیرندگان خدمات سلامت و نیز جامعه.
۳. ساماندهی فرآیند کشف و شناسایی جرائم مرتبط با سقط جنین عمدی، مطابق فرآیند کشف جرم و تنظیم گزارش (پیوست شماره ۴).
۴. ساماندهی فرآیند معرفی متخلفین به مراجع قضایی و پیگیری احکام صادره از سوی مراجع قضایی برای متخلفین، مطابق فرآیند کشف جرم و تنظیم گزارش (پیوست شماره ۴).
۵. انجام مطالعات مرتبط در خصوص برآورد فراوانی سقط جنین عمدی، علل و عوامل تاثیرگذار و راه‌ها و رویکردها پیشگیری و مقابله با آن.
۶. ساماندهی فرآیندهای انصراف از سقط مبتنی بر اصول مشاوره.
۷. نظارت بر اجرای قوانین و دستورعمل‌های مرتبط از جمله دستورالعمل ماده ۵۶ قانون (مکاتبه شماره ۱۰۷/۳۱۶۵/د تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات) و سایر دستورعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و مکاتبات مرتبط از سوی وزارت متبوع و نهادهای بالا دستی پس از استعلام وزارت متبوع.
۸. انجام هماهنگی‌های درون و برون بخشی در راستای دستیابی به اهداف ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اجرای مصوبات از جمله مصوبات ستاد ملی جمعیت، کارگروه ویژه مقابله با سقط غیر قانونی جنین ستاد ملی جمعیت، مصوبات قرارگاه جوانی جمعیت و کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سایر مصوبات مرتبط از سطوح بالاتر.

ماده ۳: اعضا

متناظر با اعضای این کارگروه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ستون دوم جدول زیر)، اعضای این کارگروه در

سطح دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به شرح جدول زیر تعیین می‌گردند:

ردیف	اعضای کارگروه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ستاد مرکزی)	اعضای (متناظر) کارگروه دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
۱	رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس (رئیس؛ به جانشینی معاون بهداشت).	معاون بهداشت (رئیس).
۲	-معاون جوانی جمعیت مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس. -رئیس اداره جوانی جمعیت مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس. -رئیس دفتر آموزش و ارتقای سلامت.	-معاون فنی دانشگاه/دانشکده. -متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای معاون/رئیس اداره/واحد جوانی جمعیت معاونت بهداشت ستاد مرکزی. -متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای کارشناس دفتر آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت ستاد مرکزی.
۳	رئیس اداره سلامت مادران مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس (دبیر).	- مدیر واحد/گروه/مدیریت جوانی جمعیت و سلامت خانواده و مدارس، معاونت بهداشت (دبیر). -کارشناس سلامت مادران واحد/گروه/مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس، معاونت بهداشت (مسئول دبیرخانه کارگروه).
۴	معاون درمان/نماینده تام‌الاختیار. -رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان. -رئیس اداره نظارت بر موسسات پزشکی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان.	معاون درمان/نماینده تام‌الاختیار. -متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای رئیس/ مدیر مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان در معاونت درمان ستاد مرکزی. -متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای رئیس/مدیر مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های در معاونت درمان ستاد مرکزی. - متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت در معاونت درمان ستاد مرکزی. - متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی در معاونت درمان ستاد مرکزی. - رئیس اداره مامایی، سلامت مادر و نوزاد دانشگاه / دانشکده. - کارشناس مادران معاونت درمان. - سایر بنا به صلاحدید دانشگاه/دانشکده.
۵	معاون آموزشی/نماینده تام‌الاختیار.	معاون آموزشی/نماینده تام‌الاختیار.
۶	رئیس سازمان غذا و دارو/نماینده تام‌الاختیار.	معاون غذا و دارو/نماینده تام‌الاختیار.
۷	رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات/نماینده تام‌الاختیار.	متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات/نماینده تام‌الاختیار.
۸	مدیرکل اداره کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات/نماینده تام‌الاختیار.	مدیر امور حقوقی/نماینده تام‌الاختیار.
۹	مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات/نماینده تام‌الاختیار.	متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات/نماینده تام‌الاختیار.
۱۰	رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستیار رسانه‌ای وزیر/نماینده تام‌الاختیار.	متناظر دانشگاهی/ دانشکده‌ای رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی/نماینده تام‌الاختیار.
۱۱	معاون تحقیقات و فناوری/نماینده تام‌الاختیار.	معاون تحقیقات و فناوری/نماینده تام‌الاختیار.
۱۲	رئیس مرکز حراست/نماینده تام‌الاختیار.	-مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه/دانشکده/نماینده تام‌الاختیار.

		-رییس مرکز حراست/نماینده تام/الاختیار. -مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی/نماینده تام/الاختیار.
۱۳	معاون فرهنگی، دانشجویی/نماینده تام/الاختیار.	معاون فرهنگی، دانشجویی/نماینده تام/الاختیار.
۱۴	مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل/نماینده تام/الاختیار.	متناظر دانشگاهی/ دانشکده ایی مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل/نماینده تام/الاختیار.
۱۵		سایر صاحب نظران/خبرگان بنا به صلاحدید رییس و دبیر کارگروه دانشگاه/دانشکده از قبیل -معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع/نماینده تام/الاختیار. -مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه/دانشکده/نماینده تام/الاختیار. -مدیر گروه زنان-زایمان دانشگاه/دانشکده/نماینده تام/الاختیار. -مدیر گروه مامایی دانشگاه/دانشکده/نماینده تام/الاختیار. -نماینده سازمان های مردم نهاد فعال در مقابله با سقط عمدی جنین. -گروه های جهادی، مردمی (مانند نفس). -نماینده بسیج دانشجویی و

ماده ۴: شرح وظایف کارگروه

شرح وظایف کارگروه به شرح زیر می باشد که به تفکیک اعضا در جدول پیوست شماره ۳ مشخص شده است.

۱. بررسی وضعیت موجود و تعیین مداخلات در راستای "پیگیری و مقابله با سقط عمدی جنین".
۲. همکاری در زمینه نظارت بر اطلاع رسانی ها و محتواهای موجود در فضاهای ارتباط جمعی/ رسانه ایی از جمله فضاهای مجازی، نشریات دانشجویی صنفی و/یا علمی و تشکل های دانشجویی.
۳. پیگیری و هماهنگی اعلام گزارش های دریافت شده از جمله از طریق سامانه ۱۹۰، مرکز ملی پاسخگویی به شکایات و/یا بازدیدهای صورت گرفته مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان در خصوص شناسایی تخلفات، شبکه های توزیع دارو و تجهیزات مورد استفاده در سقط جنین به مراجع قضایی بر اساس ماده ۵۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت. هم چنین، گزارش دوره ای هر سه ماه یکبار (فصلی) کشف موارد تخلف و برخورد با متخلفین دارویی و تجهیزات پزشکی و نیز تخطی از اجرای دستورعمل های ابلاغ شده سازمان غذا و دارو در خصوص توزیع و عرضه داروها و تجهیزات موجد سقط جنین.
۴. هماهنگی و همکاری در زمینه ثبت، بررسی، پیگیری، جمع بندی، ساماندهی و نظارت بر گزارش های مردمی و پاسخگویی ها در سامانه ها از جمله سامانه ۱۹۰.
۵. جلب مشارکت فعال بیمارستان ها در خصوص اتخاذ راهکارها/ اقدامات مناسب در زمینه "پیگیری و مقابله با سقط عمدی جنین" از جمله ثبت گزارش تخلفات.
۶. ساماندهی فرآیند(های) نظارت و پایش بیمارستان ها/ درمانگاه های دولتی و خصوصی، مراکز جراحی محدود، مطب ها، خیریه ها، داروخانه ها، داروفروشی ها و ... در زمینه آگاهی از قوانین، اجرای کامل قوانین مشتمل بر نصب پوسترها و اعلانات طی نامه شماره ۱۵۷۴۸/۳۰۰۱۳۰۲/۰۸/۳۰ معاونت بهداشت و شناسایی/ معرفی متخلفین، مطابق فرآیند پیوست شماره ۴.
۷. هماهنگی و همکاری در زمینه ساماندهی فرآیندهای شناسایی، معرفی به مراجع ذیربط از جمله قضایی، پیگیری احکام صادره، تهیه و ارایه گزارش از وضعیت اعمال قوانین، شناسایی متخلفین و برخورد با آنان در زمینه سقط عمدی جنین از قبیل معاونت، مباشرت، انجام و ... سقط جنین و/یا توزیع داروها و تجهیزات مورد استفاده در سقط جنین. هم چنین، هماهنگی با مراجع قضایی جهت تسریع در بررسی و پیگیری پرونده های مرتبط با سقط عمدی در راستای اعمال قوانین بازدارنده.
۸. اطلاع رسانی، ترویج و الزام استفاده از سامانه های اطلاعاتی بهداشتی مرتبط با داده های باروری و بارداری، به ویژه سامانه ملی باروری سالم و نظارت بر استفاده از این سامانه در کلیه بخش های دولتی و خصوصی.

۹. ارایه گزارش از فعالیت‌های مرتبط در طی جلسات کارگروه.
۱۰. حضور فعال و موثر در تمامی جلسات و پیگیری و به نتیجه رساندن مصوبات مرتبط با حوزه فعالیت توسط هر یک از اعضا.
۱۱. انجام هماهنگی‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه فعالیت در درون و بیرون دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.
۱۲. تدوین و تنظیم مکاتبات و اطلاع رسانی‌های مرتبط، از جمله در خصوص فهرست داروها و تجهیزات دارای ممنوعیت استفاده در مطب (نامه شماره ۴۰۰/۲۲۷۶۴/۴۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴)، دستورعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قوه قضاییه (نامه شماره ۴۰۰/۱۰۰۱۷/۴۰۰ تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸) و شایان ذکر است که برنامه مدون به همراه زمان‌بندی اجرایی شامل انجام بازرسی دوره‌ای هر سه ماه یکبار (فصلی) معاونت‌های غذا و دارو از داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع کننده دارو و تجهیزات پزشکی در خصوص نحوه توزیع و عرضه داروها و تجهیزات موجد سقط جنین، مطابق دستورعمل‌های ابلاغ شده، تهیه و ضمن اطلاع رسانی قوانین و دستورعمل‌های مربوطه از طریق سامانه‌های این سازمان و دانشگاه‌ها موارد شکایات، تخلفات و گزارشات ثبت و اقدام لازم انجام پذیرد.
۱۳. اطلاع رسانی به سازمان نظام پزشکی و نیز کلیه پزشکان به‌ویژه متخصصین زنان- زایمان، ماماها و پزشکان عمومی در بخش خصوصی و دولتی در ارتباط با قوانین و دستورعمل‌های مرتبط با "پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین"، مطابق مکاتبات وزارت متبوع.
۱۴. اطلاع رسانی به کلیه داروخانه‌ها، داروفروشی‌ها، اصناف و اتحادیه‌های دارویی از جمله داروهای گیاهی-سنتی، تجهیزات پزشکی و ... در خصوص قوانین مرتبط با "پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین".
۱۵. همکاری و هماهنگی در زمینه تدوین و تنظیم محتوای اطلاع رسانی برای گروه‌های هدف مختلف از جمله کارکنان و ارایه دهندگان خدمات، پزشکان، ماماها، داروسازها، داروفروش‌ها، رادیولوژیست‌ها، جامعه و
۱۶. همکاری در زمینه اطلاع رسانی به فعالان حوزه طب سنتی، ایرانی و مکمل در خصوص ممنوعیت شرعی، قانونی، اخلاقی و حقوقی سقط عمدی جنین.
۱۷. اطلاع رسانی در خصوص موضوعات قانونی و شرح وظایف مرتبط کارکنان و مدیران وزارت بهداشت در این زمینه و نظارت بر اجرای صحیح آن.
۱۸. تولید محتوای خبری و اطلاع رسانی در خصوص تخلفات و اقدامات قانونی صورت پذیرفته.

۱۹. همکاری و هماهنگی در زمینه تدوین و تنظیم محتواهای آموزشی برای گروه‌های هدف کارکنان، ارایه دهندگان خدمت، اساتید، اعضای هیئت علمی و دانشجویان اعم از پزشکی و غیر پزشکی و ...
۲۰. هماهنگی و پیگیری برگزاری دوره‌های توانمندسازی کارکنان و اعضای هیئت علمی، از جمله دوره‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی ویژه ماماها، پزشکان عمومی و متخصصین زنان- زایمان و ... با موضوعات مرتبط با "پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین" از جمله قوانین.
۲۱. تولید محتواهای آموزش مجازی در خصوص "پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین" به منظور برگزاری دوره‌های مجازی مرتبط.
۲۲. هماهنگی و همکاری لازم جهت اخذ مجوز برگزاری دوره‌های آموزشی توجیهی (از جمله بدو خدمت) جهت متخصصین، پزشکان، ماماها، مراقبین سلامت، بهورزان و سایر گروه‌های هدف ارایه دهنده خدمت با احتساب امتیاز ویژه در ارزشیابی سالیانه.
۲۳. شناسایی تناقضات احتمالی با مواد مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در برنامه (کوریکولوم)های آموزشی و گزارش آن به کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین.
۲۴. ارایه پیشنهاد در خصوص سرفصل(های) مرتبط با موضوع "پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین" در برنامه (کوریکولوم)های آموزشی.
۲۵. آموزش مربیان دوره جامع آموزشی، فرهنگ سازی و رسانه فرزندآوری و نیز مربیان آموزش هنگام ازدواج در خصوص عوارض و عواقب سقط عمدی جنین.
۲۶. هماهنگی و پیگیری برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص (محتوای) انصراف از سقط عمدی جنین توسط معاونت بهداشت.
۲۷. تهیه محتواهای آموزشی و اطلاع رسانی تخصصی و عمومی در قالب پوستر، انیمیشن، تیزر، داستان کوتاه، کتابچه، اینفوگرام/ گرافیک متحرک و ...
۲۸. هماهنگی و همکاری با صدا و سیما استانی در خصوص تولید و پخش محتواهای مرتبط.
۲۹. ترویج تحقیقات مرتبط با فراوانی، علل و راهکارهای مداخلاتی پیشگیرانه در موضوع سقط عمدی جنین از طریق تعیین اولویت و تخصیص اعتبار.

۳۰. تقویت همکاری در زمینه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی (تولید محتوا) در خصوص معضلات/ممنوعیت سقط عمدی جنین از دیدگاه‌های سلامتی، شرعی/فقهی، قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی سقط عمدی جنین با استفاده از ظرفیت اقشار مختلف بسیج، گروه‌های مردمی نظیر مجمع ملی جمعیت و گروه مردمی نفس (نجات فرزندان سقط)، خیریه‌ها و ...
۳۱. ترغیب برگزاری پویش دانشگاهی/دانشکده‌ای از قبیل مسابقه، همایش و ... در زمینه راه‌های پیشگیری از سقط عمدی جنین.
۳۲. ترغیب فراهم آوردن تسهیلات مشاوره انصراف از سقط با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و خیرین.
۳۳. زمینه‌سازی جهت استفاده از ظرفیت‌های گروه‌های مردمی، جهادی مانند بسیج جامعه پزشکی، بسیج دانشجویی، نفس و ... در امر مهم پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین.
۳۴. سایر وظایف بر حسب نیازها و اولویت‌های دانشگاه/دانشکده و بر اساس تصمیمات کارگروه.

ماده ۵: زمان برگزاری جلسات

کارگروه حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد. جلسات با حضور اکثریت اعضا (نصف بعلاوه یک) رسمیت می‌یابند.

ماده ۶: اعلام زمان جلسات

دبیر کارگروه موظف است روز، ساعت، مکان تشکیل جلسه و نیز دستور جلسه را، به صورت کتبی، حداقل یک هفته قبل از جلسه کارگروه به اطلاع اعضا برساند.

ماده ۷: اعلام عدم حضور در جلسه

کلیه اعضا موظف به حضور در جلسات هستند. در صورتیکه عذر موجهی برای عدم حضور در جلسه وجود داشته باشد، بایستی مراتب قبل از تشکیل جلسه با ذکر علت، به صورت کتبی، به دبیر کارگروه اعلام گردد. در صورت عدم حضور اعضا بدون هماهنگی/اطلاع قبلی به رییس/دبیر کارگروه، مراتب به ریاست دانشگاه/دانشکده اعلام خواهد شد.

در صورت غیاب رییس کارگروه، دبیر کارگروه عهده‌دار وظایف وی خواهد بود.

حضور نماینده(گان) واحد/گروه/مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس، معاونت درمان و مدیریت امور حقوقی در تمام جلسات الزامی است.

ماده ۸ : اخذ تصمیمات در جلسه

کارگروه در جلسات بر اساس دستور کار هر جلسه به موضوعات رسیدگی می نماید. اتخاذ تصمیم در جلسات با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه (بیش از نیمی از اعضا) به تصویب رسیده و پس از تایید رییس کارگروه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹ : ابلاغ مصوبات جلسات

مذاکرات جلسات در صورت جلسه هر جلسه آورده شده و به امضاء اعضا رسانیده خواهد شد. مصوبات جلسات کارگروه که توسط دبیر کارگروه به معاونت ها/مراکز/ادارات/مدیریت ها/گروه ها/واحدها و ... ذیربط ابلاغ خواهد شد، باید دارای مهلت زمانی و مسئول انجام باشند.

ماده ۱۰ : اجرای مصوبات

کلیه معاونت ها/مراکز/ادارات/مدیریت ها/گروه ها/واحدهای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مکلفند در جهت تسهیل اجرای مصوبات کارگروه همکاری لازم با دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی را به عمل آورند. تبصره ۱: عدم اجرای مصوبات جلسات کارگروه بایستی از سوی بالاترین مقام دانشگاه/دانشکده (رییس دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی) پیگیری شود.

ماده ۱۱ : دبیرخانه کارگروه

دبیرخانه این کارگروه در گروه سلامت مادران، واحد/گروه/مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر می باشد.

ماده ۱۲ : دعوت از سایر اعضا

دبیر کارگروه می تواند با نظر/تایید رییس کارگروه، از ادارات و سازمان های دیگر مانند سازمان نظام پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، دادسرای جرایم پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه جهت حضور در جلسات کارگروه دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۳: گردش کار طرح موضوعات در جلسات کارگروه

درخواست یا پیشنهاد رسیده به دبیرخانه کارگروه توسط دبیر کارگروه بررسی و موضوعات مرتبط پس از تایید رییس کارگروه برای اتخاذ تصمیم نهایی در جلسات کارگروه مطرح می‌شوند.

تبصره ۱: مصوبات جلسات ستاد ملی جمعیت، کارگروه سقط ستاد ملی جمعیت و نیز کارگروه پیشگیری و مقابله با سقط عمدی جنین وزارت متبوع لازم است در تمامی جلسات کارگروه مطرح و اجرایی شوند.

تبصره ۲: دبیرخانه موظف است مصوبات جلسات تبصره ۱ را حداقل دو ماه یکبار به اطلاع/استحضار اعضای کارگروه برساند.

تبصره ۳: اعضای کارگروه موظف هستند پیشنهادات خود در حیطه شرح وظایف مربوطه را حداکثر تا ۲ هفته قبل از هر جلسه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

ماده ۱۴: گزارش فعالیت‌های کارگروه

دبیر کارگروه موظف است با هماهنگی رییس کارگروه، گزارشی از اقدامات کارگروه را بر اساس قالب ارایه شده در پیوست ۱ (قالب گزارش فصلی از فعالیت‌های کارگروه) را به صورت فصلی تهیه و جمع‌بندی آن را هر شش ماه با امضای معاون بهداشتی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به معاونت بهداشت وزارت متبوع ارسال نماید. فرآیند چرخه اقدامات و برون‌دادهای کارگروه در پیوست ۲ آورده شده است.

این شیوه‌نامه با ۱۴ ماده، ۴ تبصره و ۴ پیوست از زمان ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.